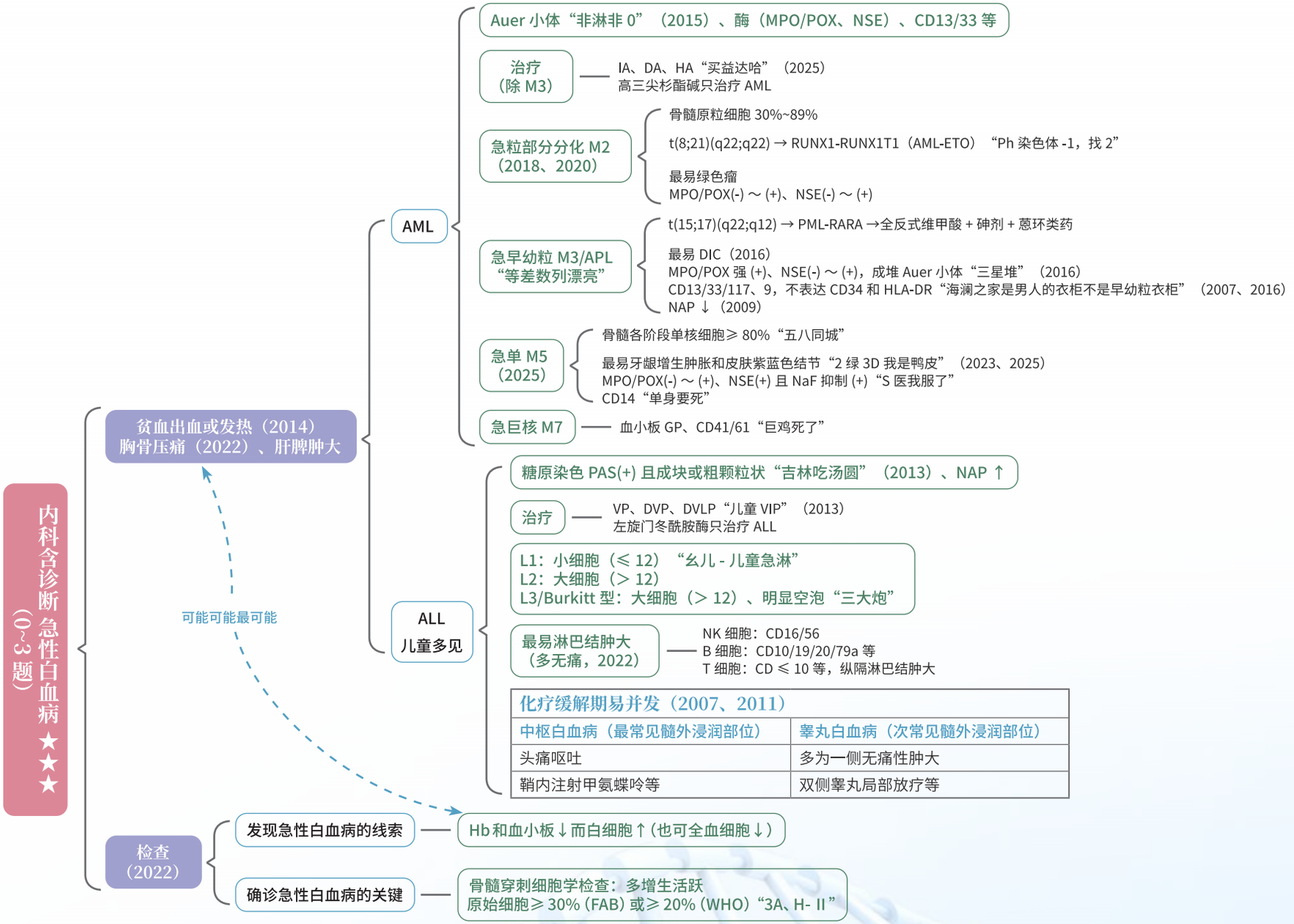

内科含诊断 急性白血病 ★★★（0~3 题）
贫血出血或发热（2014）胸骨压痛（2022）、肝脾肿大
AML
Auer 小体“非淋非 0”（2015）、酶（MPO/POX、NSE）、CD13/33 等
治疗（除 M3）
IA、DA、HA“买益达哈”（2025）
高三尖杉酯碱只治疗 AML
急粒部分分化 M2（2018、2020）
骨髓原粒细胞 30%~89%
t(8;21)(q22;q22) → RUNX1-RUNX1T1（AML-ETO）“Ph 染色体 -1，找 2”
最易绿色瘤
MPO/POX(-) ～ (+)、NSE(-) ～ (+)
急早幼粒 M3/APL“等差数列漂亮”
t(15;17)(q22;q12) → PML-RARA →全反式维甲酸 + 砷剂 + 蒽环类药
最易 DIC（2016）
MPO/POX 强 (+)、NSE(-) ～ (+)，成堆 Auer 小体“三星堆”（2016）
CD13/33/117、9，不表达 CD34 和 HLA-DR“海澜之家是男人的衣柜不是早幼粒衣柜”（2007、2016）
NAP ↓（2009）
急单 M5（2025）
骨髓各阶段单核细胞≥ 80%“五八同城”
最易牙龈增生肿胀和皮肤紫蓝色结节“2 绿 3D 我是鸭皮”（2023、2025）
MPO/POX(-) ～ (+)、NSE(+) 且 NaF 抑制 (+)“S 医我服了”
CD14“单身要死”
急巨核 M7
血小板 GP、CD41/61“巨鸡死了”
ALL 儿童多见
糖原染色 PAS(+) 且成块或粗颗粒状“吉林吃汤圆”（2013）、NAP ↑
治疗
VP、DVP、DVLP“儿童 VIP”（2013）
左旋门冬酰胺酶只治疗 ALL
L1：小细胞（≤ 12）“幺儿 - 儿童急淋”
L2：大细胞（> 12）
L3/Burkitt 型：大细胞（> 12）、明显空泡“三大炮”
最易淋巴结肿大（多无痛，2022）
NK 细胞：CD16/56
B 细胞：CD10/19/20/79a 等
T 细胞：CD ≤ 10 等，纵隔淋巴结肿大
化疗缓解期易并发（2007、2011）
中枢白血病（最常见髓外浸润部位）
睾丸白血病（次常见髓外浸润部位）
头痛呕吐
多为一侧无痛性肿大
鞘内注射甲氨蝶呤等
双侧睾丸局部放疗等
可能可能最可能
检查（2022）
发现急性白血病的线索
Hb 和血小板↓而白细胞↑（也可全血细胞↓）
确诊急性白血病的关键
骨髓穿刺细胞学检查：多增生活跃
原始细胞≥ 30%（FAB）或≥ 20%（WHO）“3A、H- II”